melanome

Niveau : DES
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

melanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Mélanome : Épidémiologie et Introduction

Introduction

Le mélanome cutané est une tumeur maligne agressive dérivant des mélanocytes, cellules responsables de la production de pigment, et se caractérise par une capacité de dissémination métastatique significative. Il affecte de manière notable une population relativement jeune, avec un pic d'incidence observé entre 20 et 45 ans (dermatology handbook compressed-compressed). Cette néoplasie est reconnue comme une tumeur immuno-réactive, ce qui influence à la fois son développement et sa réponse aux traitements, notamment chez les populations immunodéprimées (NCCN, 2026).

Le pronostic du mélanome est multifactoriel, mais des avancées dans la détection précoce et les stratégies thérapeutiques ont conduit à un taux de survie à 10 ans de 85 à 95 % pour les tumeurs primaires (Garbe et al., 2025). Les facteurs pronostiques histologiques les plus importants incluent l'épaisseur tumorale verticale (indice de Breslow), mesurée du sommet de la couche granuleuse de l'épiderme ou de la base de l'ulcération jusqu'au point le plus profond d'invasion dermique, et la présence d'une ulcération histologique (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed). L'ulcération est définie par un défaut épidermique pleine épaisseur, l'absence de *stratum corneum* et de membrane basale, des signes de réponse de l'hôte (dépôt de fibrine, neutrophiles) et un amincissement ou une hyperplasie réactive de l'épiderme environnant (Garbe et al., 2025). Le taux mitotique, bien qu'identifié comme un facteur pronostique indépendant dans plusieurs études de population, n'est plus utilisé pour la sous-classification des mélanomes fins dans la 8ème révision du système de stadification de l'AJCC (Garbe et al., 2025). D'autres facteurs de mauvais pronostic incluent l'âge avancé, le sexe masculin et la localisation de la tumeur sur le tronc ou la tête et le cou, par rapport aux membres (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed).

Le mélanome peut métastaser par voie lymphatique ou hématogène. Environ deux tiers des métastases sont initialement confinées à l'aire de drainage des ganglions lymphatiques régionaux. Les métastases locorégionales se manifestent sous forme de métastases satellites (jusqu'à 2 cm de la tumeur primaire), de métastases en transit (situées dans la peau entre 2 cm du site primaire et le premier ganglion lymphatique drainant), de micrométastases ganglionnaires régionales (identifiées par biopsie du ganglion sentinelle et non cliniquement reconnaissables), ou de macrométastases ganglionnaires cliniquement ou radiologiquement détectables (Garbe et al., 2025). La progression tumorale est également définie par le nombre d'organes impliqués, la présence de métastases cérébrales et les niveaux sériques de lactate déshydrogénase (LDH) (Garbe et al., 2025). Le système de stadification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC), dans sa 8ème édition (AJCC v8), classe le mélanome en fonction de

l'étendue de la tumeur primaire, de sa profondeur et de la présence ou non d'ulcération (dermatology handbook compressed-compressed; Garbe et al., 2025).

Épidémiologie

L'incidence du mélanome cutané est en augmentation constante à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations de phototype clair exposées de manière excessive au soleil (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) a estimé à 325 000 le nombre de nouveaux cas de mélanome dans le monde en 2020, avec une légère prédominance masculine (174 000 hommes contre 151 000 femmes), et à 57 000 le nombre de décès (32 000 hommes contre 25 000 femmes) (Garbe et al., 2025).

Des variations géographiques importantes sont observées. Les populations de phototype clair présentent les incidences les plus élevées, avec une augmentation notable au cours des dernières décennies. L'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent les taux d'incidence les plus élevés standardisés selon l'âge, avec 42 cas pour 100 000 personnes/an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes/an chez les femmes. En Europe de l'Ouest, l'incidence est d'environ 19 cas pour 100 000 personnes/an pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18 cas pour 100 000 hommes et 14 cas pour 100 000 femmes par an. En revanche, le mélanome est rare dans les populations de couleur des pays africains et asiatiques, avec des taux d'incidence généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025).

L'analyse à long terme des registres nationaux illustre cette tendance à la hausse. Au Danemark, l'incidence du mélanome est passée de 1,1 à 46,5 pour 100 000 hommes et de 1,0 à 48,5 pour 100 000 femmes entre 1943 et 2016, avec une prédiction d'augmentation à 60,0 et 73,0 respectivement d'ici 2036. En Nouvelle-Zélande, l'incidence a augmenté de 2,7 à 81,0 pour 100 000 hommes et de 3,8 à 54,7 pour 100 000 femmes entre 1948 et 2016, bien qu'une légère diminution soit ensuite prévue. Des augmentations similaires ont été rapportées aux États-Unis via le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) depuis 1975 (Garbe et al., 2025). Cette augmentation spectaculaire de l'incidence est largement attribuée à un changement de mode de vie après la Seconde Guerre mondiale, caractérisé par des vacances ensoleillées et une exposition solaire accrue pendant les loisirs (Garbe et al., 2025). Il est estimé qu'environ 95 % des mélanomes sont attribuables à l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) (Garbe et al., 2025).

Facteurs de Risque

L'étiologie du mélanome est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs génétiques, phénotypiques et environnementaux.

Facteurs Phénotypiques et liés à l'Exposition Solaire

Les caractéristiques phénotypiques associées à un risque accru de mélanome comprennent la difficulté à bronzer, un teint clair avec une tendance aux coups de soleil, les cheveux roux

Présentation Clinique

Le mélanome, tumeur maligne issue des mélanocytes, représente la forme la plus dangereuse de cancer cutané, étant responsable de 90 % de la mortalité associée aux tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Sa présentation clinique est polymorphe, rendant son diagnostic un défi pour le clinicien. Une reconnaissance précoce est cruciale pour améliorer le pronostic, soulignant l'importance d'une approche diagnostique rigoureuse combinant l'examen clinique et la dermoscopie.

1. Approche Diagnostique Clinique Générale

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une évaluation minutieuse des lésions cutanées, en tenant compte de leurs caractéristiques macroscopiques, de leur évolution et d'une comparaison intra-individuelle. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025). Le mélanome est une tumeur agressive qui résulte de la prolifération des mélanocytes et affecte une population relativement jeune, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans (Dermatology handbook, compressed-compressed).

1.1. Caractéristiques Macroscopiques et Règles Mnémoniques

La présentation macroscopique du mélanome varie selon son sous-type, mais des caractéristiques typiques sont synthétisées par la règle ABCD (Garbe et al., 2025) :

- **A (Asymétrie)** : La lésion n'est pas symétrique, ni dans sa forme ni dans sa pigmentation.
- **B (Bords irréguliers)** : Les bords de la lésion sont déchiquetés, festonnés ou mal définis.
- **C (Couleur variable)** : La lésion présente une variabilité de couleurs, incluant différentes nuances de brun, de noir, de bleu, de rouge ou de blanc.
- **D (Diamètre)** : Le diamètre de la lésion est généralement supérieur à 5 mm.

Avec l'évolution de la tumeur, d'autres signes peuvent apparaître, tels que l'ulcération et le développement d'une composante nodulaire (Garbe et al., 2025). Il est impératif de noter que le mélanome nodulaire (MN) peut ne pas présenter ces caractéristiques diagnostiques classiques. Dans ce cas, la règle EFG est pertinente pour inciter à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025) :

- **E (Élevé)** : La lésion est surélevée par rapport à la surface cutanée.
- **F (Ferme)** : La lésion est ferme à la palpation.
- **G (Croissance rapide)** : La lésion présente une croissance rapide et visible.

Ces règles mnémoniques sont des outils précieux pour le dépistage, mais ne doivent pas remplacer un examen clinique et dermoscopique approfondi.

1.2. Stratégies d'Examen Clinique

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une approche méthodique (Garbe et al., 2025) :

• **Examen visuel corporel total de la peau** : Il vise à détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés. Cet examen doit être exhaustif, incluant les zones moins exposées comme les organes génitaux, la muqueuse

Diagnostic

Le diagnostic du mélanome cutané repose sur une approche méthodique et multidisciplinaire, intégrant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie, et, dans certains cas, le bilan d'extension et l'analyse moléculaire. L'objectif est d'affirmer la nature mélanocytaire maligne de la lésion, de déterminer son sous-type anatomoclinique, d'évaluer les paramètres pronostiques et d'établir un bilan d'extension précis pour guider la prise en charge thérapeutique.

I. Approche Clinique et Dermatoscopique

A. Diagnostic Clinique

L'examen clinique est la première étape fondamentale dans le diagnostic du mélanome. Il doit être systématique et complet, incluant un examen visuel total du corps pour détecter les lésions suspectes (Garbe et al., 2025). La présentation clinique du mélanome est variable et dépend de son sous-type (Garbe et al., 2025).

Les caractéristiques macroscopiques typiques sont résumées par la règle "ABCD" :

- **A**symétrie de la lésion.
- **B**ords irréguliers.
- **C**ouleurs variables (hétérogénéité des teintes).
- **D**iamètre supérieur à 5 mm (Garbe et al., 2025).

L'évolution de la lésion est un critère essentiel, le mélanome étant presque toujours caractérisé par une croissance et/ou un changement de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025). L'ulcération et la présence d'une composante nodulaire peuvent apparaître au cours de l'évolution tumorale (Garbe et al., 2025). La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

Des formes cliniques spécifiques peuvent rendre le diagnostic plus difficile :

- Les mélanomes hypo- ou amélanotiques, dépourvus de pigmentation, sont particulièrement difficiles à reconnaître (Garbe et al., 2025).
- Le mélanome nodulaire (MN) peut manquer des caractéristiques diagnostiques classiques de la règle ABCD (Garbe et al., 2025). Dans ce cas, la règle "EFG" est pertinente : **E**levated (surélevé), **F**irm (ferme) et **G**rowing (en croissance rapide), incitant à l'excision d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025).

Le diagnostic clinique repose également sur :

- L'analyse comparative intra-individuelle, recherchant la lésion "vilain petit canard" (ugly duckling sign), c'est-à-dire une lésion différente des autres chez le même patient (Garbe et al., 2025).

• L'évaluation de l'évolution des lésions, si une documentation antérieure est disponible (Garbe et al., 2025).

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut d'autres lésions mélanocytaires pigmentées (naevi congénitaux, atypiques, communs), des lésions pigmentées non mélanocytaires (kératose séborrhéique, lentigo actinique, hémangiome, dermatofibrome, carcinome basocellulaire pigmenté) et d'autres tumeurs non pigmentées (hémangiome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) (Garbe et al., 2025).

B. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique indispensable qui doit toujours être utilisée dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025). Une formation en dermatoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience croissante (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a montré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul pour les lésions douteuses, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % (Garbe et al., 2025). La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique avant qu'elle ne soit cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025).

Les caractéristiques dermatoscopiques du mélanome incluent généralement une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les signes spécifiques comprennent un réseau pigmentaire atypique, des points/globules/amas bruns-noirs irréguliers, des stries irrégulières, des taches/zones hyperpigmentées irrégulières, des stries/lignes blanches brillantes et des structures de régression (Garbe et al., 2025). Des critères additionnels comme le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes sont fréquents dans le mélanome invasif (Garbe et al., 2025).

Des modèles dermatoscopiques spécifiques existent pour les différents sous-types :

• **Mélanome amélanotique** : Il manque la plupart des critères dermatoscopiques pigmentaires et se caractérise par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome acral lentigineux (MAL)** : Les principales caractéristiques dermatoscopiques sont un motif en crêtes parallèles (parallel ridge pattern) et une pigmentation diffuse irrégulière, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Garbe et al., 2025 ; Garbe et al., 2025).

• **Mélanome de Dubreuilh (LMM)** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique sur le visage comprend quatre motifs séquentiels : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales (Garbe et al., 2025). L'importance de caractéristiques additionnelles telles qu'un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al.,

2025).

• **Mélanome sous-unguéal** : Il se manifeste comme une bande unguéale pigmentée, caractérisée dermatoscopiquement par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, et une extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome des muqueuses** : Il est caractérisé dermatoscopiquement par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

Une documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). En l'absence de dermatoscopie mais avec une forte suspicion clinique, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

C. Outils Complémentaires d'Imagerie Cutanée

Pour les patients à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de naevi), la photographie corporelle totale (2D ou 3D) et la dermatoscopie numérique séquentielle contribuent significativement à la détection précoce du mélanome (Garbe et al., 2025 ; Ortiz, 2024). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les individus à haut risque présentant de multiples naevi atypiques, facilitant la détection des mélanomes et réduisant le nombre d'excisions inutiles (Garbe et al., 2025). La microscopie confocale par réflectance peut également améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, si disponible (Garbe et al., 2025). L'intelligence artificielle (IA) peut aider à la détection de nouvelles lésions, à l'identification des changements et à la fourniture de scores de risque pour les lésions mélanocytaires, bien que la prudence soit de mise lors de l'extrapolation des résultats d'études expérimentales à la pratique clinique réelle (Garbe et al., 2025).

II. Diagnostic Histopathologique

A. Principes Généraux de l'Exérèse Biopsique

Si un mélanome est cliniquement suspecté, le diagnostic doit imp

Traitement

Le traitement du mélanome cutané est une entité complexe et multidisciplinaire, dont les stratégies thérapeutiques ont été profondément transformées par l'avènement des immunothérapies et des thérapies ciblées. La prise en charge repose sur une évaluation rigoureuse du stade de la maladie et des caractéristiques moléculaires de la tumeur, nécessitant une collaboration étroite au sein d'une équipe oncologique interdisciplinaire ("Tumor Board") (Garbe et al., 2025).

Principes Généraux du Traitement du Mélanome Cutané

Excision Chirurgicale du Mélanome Primitif

Le traitement initial du mélanome primitif reste l'excision chirurgicale complète (Garbe et al., 2025). Pour des raisons diagnostiques, une biopsie excisionnelle avec une marge clinique minimale (1-3 mm) est privilégiée afin d'obtenir un spécimen optimal pour l'analyse histopathologique et l'évaluation des marges d'exérèse (Garbe et al., 2025). Les biopsies incisionnelles doivent être évitées lorsque l'excision est techniquement réalisable, car elles peuvent entraîner des erreurs diagnostiques dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'épaisseur de Breslow. Cependant, elles peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic dans des cas spécifiques, tels que les lentigos malins étendus de la tête et du cou, ou les mélanomes acraux ou muqueux (Garbe et al., 2025). Les mélanomes cutanés sont excisés avec des marges de sécurité de un à deux centimètres (Garbe et al., 2025).

Biopsie du Ganglion Sentinelle (BGS)

Pour une classification correcte du stade et une décision thérapeutique éclairée, une biopsie du ganglion sentinelle doit être proposée aux patients présentant une épaisseur tumorale ≥ 1,0 mm ou ≥ 0,8 mm avec des facteurs de risque histologiques additionnels (Garbe et al., 2025). Il est important de noter qu'à ce jour, cette approche n'a pas démontré de bénéfice clair en termes de survie globale (Garbe et al., 2025).

Traitement des Formes Localisées et Loco-régionales

Thérapies Néoadjuvantes

Les thérapies néoadjuvantes représentent une stratégie émergente dans la prise en charge du mélanome de stade avancé résécable.

Pembrolizumab — Mélanome cutané de stade IIIB-IV clinique et résécable

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Modéré (Seth et al., 2023)

> Le pembrolizumab (maximum de trois cures de 200 mg une fois toutes les 3 semaines) suivi d'une résection et d'un traitement adjuvant par pembrolizumab (maximum de 15 cures de 200 mg une fois toutes les 3 semaines) doit être proposé aux patients atteints de mélanome cutané de stade IIIB-IV clinique et résécable (Seth et al., 2023).

Ipilimumab plus Nivolumab — Mélanome avec maladie macroscopique cliniquement détectée et résécable

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : aucune donnée disponible dans les sources

> Une thérapie néoadjuvante avec ipilimumab plus nivolumab, suivie d'une résection chirurgicale complète et d'une thérapie adjuvante en fonction de la réponse pathologique et du statut BRAF, peut être proposée (Garbe et al., 2025).

Les patients atteints de mélanome cutané de stade IIIB-IV clinique et résécable devraient être orientés vers des essais cliniques de thérapie néoadjuvante lorsque cela est possible (Seth et al., 2023).

Thérapies Adjuvantes

Les thérapies adjuvantes sont proposées après résection complète de la maladie pour réduire le risque de récidive. Elles sont indiquées dans les mélanomes de stade IIB-IV complètement réséqués (Garbe et al., 2025).

Mélanome de Stade IIB ou IIC Réséqué

Pembrolizumab ou Nivolumab — Mélanome de stade IIB ou IIC réséqué

> Essai : CheckMate 76K (pour le nivolumab) (Seth et al., 2023)

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Modéré (Seth et al., 2023)

> Le pembrolizumab ou le nivolumab adjuvant doivent être proposés aux patients atteints de mélanome de stade IIB ou IIC réséqué (Seth et al., 2023). La recommandation en faveur du nivolumab est basée sur la publication d'un résumé de conférence de CheckMate 76K, sous réserve que la publication complète des données ne contredise pas ce résumé (Seth et al., 2023).

Il n'est pas recommandé de proposer une thérapie adjuvante aux patients atteints de mélanome de stade IIA réséqué en dehors d'un essai clinique (Seth et al., 2023).

Mélanome de Stade IIIA-D Réséqué

Mélanome de Stade IIIA-D avec statut BRAF sauvage

Nivolumab ou Pembrolizumab — Mélanome de stade IIIA-D réséqué, BRAF sauvage

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Élevé (Seth et al., 2023)

> Pour les patients atteints de mélanome de stade IIIA-D réséqué et de statut BRAF sauvage, le nivolumab (pendant 52 semaines) ou le pembrolizumab (pendant 52 semaines) doivent être proposés (Seth et al., 2023). L'ipilimumab et l'interféron à haute dose ne sont pas recommandés en routine pour la thérapie adjuvante (Seth et al., 2023).

Les patients atteints de mélanome de stade IIIA avec une métastase ganglionnaire sentinelle microscopique < 1 mm de diamètre n'ont pas été inclus dans les essais randomisés évaluant l'efficacité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire en thérapie adjuvante. Ces patients ont un pronostic relativement meilleur et un risque de récidive plus faible. Par conséquent, le traitement doit être individualisé après discussion du rapport risque-bénéfice avec ces patients (Seth et al., 2023).

Mélanome de Stade IIIA-D avec mutation BRAF V600

Dabrafenib plus Trametinib — Mélanome de stade IIIA-D réséqué avec mutations BRAF V600E ou V600K

> Essai : COMBI-AD (Long et al., 2017)

> Design : Essai de phase 3, randomisé, contrôlé par placebo, en double aveugle. Patients adultes (≥18 ans) ayant subi une résection complète d'un mélanome cutané de stade IIIA (limité aux métastases ganglionnaires >1 mm), II

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de la prise en charge post-thérapeutique, visant à optimiser le pronostic et la qualité de vie. Ce programme structuré s'appuie sur des objectifs clairs, bien que l'impact de la surveillance intensive sur la survie n'ait pas été définitivement prouvé par des essais randomisés prospectifs, même avec l'avènement de thérapies plus efficaces pour le mélanome avancé (NCCN, 2026). Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la fréquence et la durée optimales du suivi (NCCN, 2026).

1. Objectifs et Justification de la Surveillance Post-Mélanome*

Bibliographie

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• dermatology handbook compressed-compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2 Treatment – Update 2024

• nmsc

• Robert et al. - 2015 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Long et al. - 2017 - Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF -Mutated Melanoma